

O AMOR FUNDANTE

Uma reflexão sobre a relação de amor e cuidado com bebês

Camila Melissa de Souza

Este trabalho é sobre uma possível relação entre filha(o) e mãe/cuidadores/responsáveis e seus possíveis desdobramentos libidinais, amorosos e eróticos. Para isso, utilizei as Teorias da Sexualidade Infantil, de 1905 e A Organização Genital Infantil, de 1923, ambas de Sigmund Freud, e a técnica da Shantala, descrita pelo obstetra Frédérick Leboyer em 1918, que consiste em uma arte tradicional indiana de massagem para bebês.

Sabemos, ao longo de nossas trajetórias individuais e coletivas, a importância dos primeiros anos de vida e, sobretudo, das primeiras experiências vividas com o outro. Chegamos a este mundo através de um encontro. O encontro entre um espermatozoide com um óvulo, encontro este que pode acontecer corpo a corpo, ou não. Encontro entre pessoas que consciente ou inconscientemente, escolheram ter um bebê. Considerando aqui o processo de concepção heterossexual, através do ato sexual e os processos de fertilização in vitro, de adoção e de todas as possibilidades de constituição de uma família humana. O desejo concretizado nesse encontro humano diz, entre outras coisas, sobre um desejo infantil destes adultos, àquele vinculado aos seus complexos infantis, fantasias e identificações primárias. Freud foi revolucionário ao perceber e estudar a constituição psíquica dos pequeninos humanos, e depois seus contemporâneos, ao se debruçarem profundamente na relação materna (entendendo-se aqui materna como a função desempenhada por qualquer pessoa que se disponha a cuidar e investir no bebê) e seus desdobramentos para a vida consciente e inconsciente dos bebês. Melanie Klein e Donald Winnicott tiveram papel fundamental nesta área da psicanálise.

Leboyer dizia que é necessário que conversemos com o bebê para além da palavra, ele falava da necessidade de conversarmos com sua pele, com suas costas, sua barriga, com sua fome quando essa se manifesta, ou seja, estabelecer vínculo com o corpo daquela(e) recém-chegado ao mundo como uma maneira de aliviar e algumas vezes diminuir as proporções do sofrimento deste. Diminuir a aridez do deserto que se encontra o bebê após o nascimento. Freud também nos mostrou a importância de alimentar a relação e o ser com contato físico, calor e investimento libidinal. São fatores determinantes de sobrevivência e o necessário para o surgimento do inconsciente humano. Ou seja, não sobrevivemos só com comida, sobrevivemos com amor.

Laboyer traz uma questão “Onde começa a vida? E quando?”, alguns dizem que é com o nascimento, mas se pensarmos biológica e psicanaliticamente, a vida do bebê começa antes da separação do corpo que habita. Seja porque ainda no ventre o bebê

escuta, se movimenta, chupa o dedo e dorme, seja porque este pequeno ser já existe nas fantasias dos pais e daqueles que anseiam por sua chegada. Os adultos que fantasiam com sua aparência, com experiências que viverão juntos, com possíveis traços de personalidade e que interagem com o bebê mesmo sem ainda poderem ver e tocar seu pequeno corpo. Sendo este último um simples ato (tocar), mas ao mesmo tempo complexo e grandioso que inicia a erotização do corpo humano, o cuidado através do toque. Freud (1905, pg.73) nos alertou sobre a negligência do fator da sexualidade infantil, pois acreditávamos, e aqueles que não se debruçam sob a psicanálise passam ainda mais tempo ou uma vida toda, acreditando que a pulsão sexual está ausente na infância, que esta surge somente no período denominado puberdade. Um dos motivos para essa crença repousa em nossa amnésia infantil, ou seja, períodos esquecidos de nossa vida, que poderiam nos lembrar o desenvolvimento de nossa sexualidade e que tem íntima relação com a cultura. Nossa própria educação cultural não nos permite que tenhamos acesso às memórias deste período de nossas vidas. Todavia, não se trata de um verdadeiro desaparecimento das impressões da infância, mas de uma amnésia semelhante à que observamos nos neuróticos em relação a vivências posteriores, sua essência estando em um afastamento dessas vivências da consciência, através do recalque.

E uma mãe, como nasce? Quando nasce uma mãe? Para essa pergunta, podemos levar em conta um pouco das duas direções consideradas acima, ou seja, já existe uma mãe antes do nascimento do bebê, que nasce com as fantasias, os desejos e vontades de cada mulher e há outro nascimento que se concretiza com o real, com a real chegada física do bebê. Aqui estou chamando de mãe qualquer pessoa que se dispõe ao cuidado de um bebê. Pode ser uma mulher cisgênero heterossexual, uma mulher cisgênero homossexual, uma mulher transsexual, um homem transsexual, duas ou mais pessoas que se identificam com o gênero feminino e se relacionam sexualmente, enfim, toda e qualquer relação em que seja possível dar origem a uma nova vida, incluindo os processos assistidos de gravidez (fertilização in vitro e inseminação intrauterina). Com o bebê real nasce uma mãe/cuidador real. Lembrando que, se nascer mãe é uma tarefa densa, que atravessa a pessoa de diferentes formas, seja pelo excesso hormonal existente agora em seu corpo, pelas violências que sofre diariamente através das falas e atitudes de outras pessoas ou pelos lutos que atravessa neste processo de constituir-se outra coisa. Winnicott (1999, pg. 118) fala na imensa contribuição que uma mãe/cuidador tem

para o sujeito e sobretudo, para a sociedade, e alerta que a aceitação dessa enorme contribuição vem na vida adulta, a criança não sabe nada dessa dependência absoluta em que se encontra. Mas voltando às fantasias da (futura) mãe/cuidador, sabemos a importância destas para a psicanálise, uma vez que são uma das responsáveis pela nossa sobrevivência neste mundo. As fantasias da pessoa gestante estão vinculando-a ao bebê, em uma esfera ainda imaginária desse outro. Não é incomum casos de adoecimento psíquico no puerpério porque nessa fase se inicia um novo luto. A perda da barriga que gestava o bebê e muitas vezes a perda das fantasias com o encontro real com o bebê. Essa(e) que nasceu se parece com aquilo que eu imaginei? Que posição ocupo agora que não estou mais gestante?

As fantasias estão dos dois lados na relação, ainda no primeiro ano de vida, os bebês aprendem a fantasiar com a satisfação de suas pulsões e necessidades, nos minutos tristes até a chegada da mãe ou da/do responsável. O amor surge futuramente para satisfazer as pulsões.

As maneiras de relacionar-se emocional e fisicamente com o bebê ajuda a criança a aceitar o mundo e a sorrir para a vida (Leboyer, 2009). Mais que isso, com um vínculo de boa qualidade, ou seja, um vínculo pautado na confiança, no respeito e na disponibilidade, a criança/bebê sabe a quem recorrer em uma situação de perigo ou emergência. O respeito e a confiança nessa relação possibilitarão que a criança crie autonomia e ao mesmo tempo saiba que tem com quem contar, permite que viva os medos inatos da existência humana com mais tranquilidade. Segundo o mesmo autor, com o bebê nasce o medo, esse sentimento que não nos abandonará até nossa morte e que são as pessoas responsáveis por cuidar do bebê, que com um pouco de inteligência, tato e disposição poderão mudar alguma coisa na travessia entre segurança e insegurança. É a relação mãe-filha(o) que funda o psiquismo de uma criança, porque nós, humanos, só nos tornamos humanos na relação com o outro, é através do laço afetivo primário que podemos vir a ser humanos. Este laço afetivo que possibilitará o vínculo se estabelece a partir do contato físico com o bebê. A relação com os pais e com aqueles que cuidam, será a base de muitas relações futuras. Para os bebês humanos, a afetividade é algo que pode surgir com o contato pele a pele.

Falando agora sobre as relações futuras e escolhas objetais, Freud (1905/1923) afirmava que “com frequência ou regularmente, já na infância é realizada uma escolha de objeto semelhante à que vimos como característica da fase de desenvolvimento da

puberdade”. Muito possivelmente a maioria de nós viveu esse momento, independente da identidade de gênero. A pessoa cuidadora fez um investimento libidinal na filha(o) e este passou a relacionar-se auto eroticamente, graças ao investimento a que foi submetido e mais tarde, as relações primárias serviram de base para as relações amorosas, sexuais e afetivas que construirá em sua vida. Lembremos que a vida sexual da criança se diferencia bastante da vida sexual do adulto, pois a primazia dos genitais não chega a ocorrer na infância. A jornada libidinal desenvolvida na relação primária tem a ver com a possibilidade de a criança constituir-se sujeito, ser capaz de se reconhecer como unidade e entender-se como possuinte de um corpo. Corpo este revestido de uma pele que é o invólucro de uma alma, que se constitui de consciente e inconsciente. É interessante pensar que para Freud (1905) o serviço da reprodução humana é a última fase por que passa a organização sexual, assim sendo, ao alcançarmos a última fase estamos dando origem a uma nova vida humana que inevitavelmente passará pelas mesmas fases do desenvolvimento sexual que passamos. Mas então ele estava dizendo que não haveria fases posteriores a fase reprodutiva? Hoje já sabemos que algumas ideias freudianas não são mais tão bem vindas justamente por seu caráter conservador e machista. Há uma complexidade na sexualidade humana que talvez ele não pudesse considerar em sua época. Só um corpo, sem psiquismo, não é capaz de dar início a um processo mental, mas, se levarmos em conta a transmissão psíquica que está vinculada a toda história da espécie, existe algo já inscrito nesse ser sem psiquismo? Leboyer (2009) citando a transmissão da técnica de massagem entre as mulheres indianas disse que “nos países que preservaram o profundo sentido das coisas, as mulheres ainda se recordam disso tudo, aprenderam com as mães e ensinarão às filhas”. O corpo que recebeu a massagem é o mesmo corpo que gestou e pariu esse novo corpo que aprenderá sobre a técnica.

A relação estabelecida entre os cuidadores e o bebê é um importante canal de comunicação que dirá ao recém-chegado(a) se o mundo é um lugar agradável de se estar ou não. A técnica da Shantala pode ser interpretada como uma das maneiras possíveis de erotizar libidinalmente o corpo do bebê, mas pessoalmente me encanta mais a maneira como a técnica é uma grande e poderosa ferramenta de amar e ensinar a amar. A dependência total que um bebê tem de um adulto nos coloca uma tarefa densa, porque são os adultos que cuidam os responsáveis por proporcionar sossego ao corpo que sofre com os novos e interessantes sentimentos e sensações físicas. Por exemplo com a fome.

Quando a fome chega é preciso que ele espere a resposta do ambiente até que essa sensação monstruosa seja dissipada. O bebê sofre e se inquieta, se inquieta com o desassossego. Desassossego que permanece até que, finalmente, do deserto exterior em que o mundo se fez vem alguma coisa (alguém) que por fim aquieta o monstro desperto lá dentro. (Leboyer, 2009, pg.17)

Fora, dentro...
Eis o mundo dividido em dois.
Dentro, a fome.
Fora, o leite.
Nasceu
o espaço
Dentro, a fome
fora, o leite.
E, entre os dois,
a ausência,
a espera,
sofrimento indizível.
E que se chama
tempo.
E é assim
que tão somente
do apetite,
nasceram
o espaço
e a existência.

Uma vez escutei de uma doula que as contrações do trabalho de parto são o abraço que corpo da pessoa gestante dá no bebê antes de sua expulsão, uma despedida. O corpo dessa pessoa esteve por 9, às vezes 10 meses, convivendo com outro corpo dentro. O alimentando, acolhendo e dividindo sensações. O momento da separação não aconteceria sem um forte abraço. Abraço este que é responsável por “ativar” muitas funções biológicas do bebê. Para Freud as marcas das primeiras experiências ficam inscritas no corpo e nos acompanham para toda a vida. Marcas físicas, sentidas no corpo

e que são a base para muitas determinações psíquicas futuras. Para Leboyer, as marcas também estão inscritas e mais que isso, a marca do momento do nascimento se circunscreve na alma e na pele. A pele, costas, cada cantinho tocado desse corpo não esquecerão a força do primeiro abraço.

Um outro aspecto importante é o que diz respeito as organizações da vida sexual, fases de desenvolvimento que progridem até o momento em que as zonas genitais assumirão papel predominante, ou não. O bebê ao nascer encontra-se na primeira fase pré-genital, que chamamos fase oral, ou ainda, fase canibal. Nesse momento da vida, a atividade sexual se encontra fundida com a ingestão de alimentos. Num primeiro momento o leite materno ou fórmula, e em um segundo momento a introdução de novos alimentos (após os 6 meses de vida ou mais). Como diz Freud (1905, pg. 108) correntes opostas ainda não estão diferenciadas em seu interior. A meta sexual nessa fase consiste na incorporação do objeto, seja através do ato de sugar ou de chupar, a meta é a obtenção de prazer. Lembremos que o processo de incorporação tem relação íntima com a identificação e, a primeira identificação do bebê é com o outro, a identificação primária tem a ver com “ser como esta/este”. A identificação é a mais antiga ligação afetiva.

O nascimento, assim como a morte, é uma experiência comum a todos os humanos. Concretamente comum, REALmente comum, porque no sentido emocional cada um sentiu o nascimento de forma ímpar. Todos estivemos dentro e depois fora de um outro corpo, que foi responsável pela nossa existência e sobrevivência. Leboyer (2009, pg.22) diz “nos bebês, a pele transcende a tudo, é ela o primeiro sentido, é ela que sabe.” Essa pele sabe também por conta das vivências de seus antepassados, há uma inscrição.

Para finalizar, considero de extrema importância lembrar que, cuidar da pessoa que gesta e do bebê recém-nascido é uma tarefa que precisa envolver toda a sociedade, é um trabalho comunitário. A individualização do cuidado nos adocece. Mulheres, homens, mães, pais, pessoas não binárias, famílias adotantes e biológicas, famílias de amigos, famílias heterossexuais, homossexuais, famílias transexuais, toda a civilização, e todos os formatos possíveis de ser mulher, mãe e família neste mundo, o cuidado precisa ser uma pauta cada vez mais recorrente nos debates e se pensar conjuntamente na importância das pessoas com útero para a manutenção, permanência e existência da vida. Entender o cuidado como um trabalho e lutar por seu reconhecimento e

valorização. Pensar nos efeitos/desdobramentos saudáveis e não saudáveis que a relação das pessoas adultas com os bebês e crianças acarretam e como todos nós, enquanto sociedade, estamos lidando com isso. Falar de amor, sempre. Há nisso qualquer coisa que as palavras não sabem expressar.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRAFICAS

FREUD, S. Obras completas, volume 16. A organização genital infantil *In* O eu e o id, “autobiografia” e outros textos. São Paulo: Companhia das letras, 2011.

FREUD, S. Obras completas, volume 6. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade. 1ª ed. – São Paulo: Companhia das letras, 2016.

LEBOYER, F. Shantala: uma arte tradicional: massagem para bebês. 8ª ed.rev. – São Paulo: Editora Ground, 2009.

WINNICOTT, D.W. Tudo começa em casa. São Paulo: Martins Fontes, 1999.